

אירוע מזנטרי (Acute Mesenteric Ischemia)

אירוע מזנטרי חריף הוא מצב שבו העורקים המזנטריים אינם מזרימים מספיק דם, כך שהמעיים הופכים לאיסכמיים ולבסוף נמקיים. אף שזהו מצב יחסית נדיר לעומת אוטם שריר הלב (MI), שבץ מוחי או תסחיף ריאות (PE), זה עדיין מצב חירום שיש להכיר.

הגורמים לאירוע מזנטרי יכולים להיות עורקיים או ורידיים. גורמים עורקיים מחולקים לחסימתיים, תרומבטיים או תסחיפיים.

כלומר יש ארבעה סוגים של אירוע מזנטרי:

- 1 NOMI (non-occlusive mesenteric ischemia): אירוע לא חסימתי עורקי אקוטי
- 2 AMAT (acute mesenteric arterial thrombosis): אירוע תרומבטי עורקי
- 3 AMAE (acute mesenteric arterial emboli): אירוע תסחיפי עורקי
- 4 MVT (mesenteric venous thrombosis): אירוע תרומבטי ורידי

ביותר מ-80% מהמקרים זהו MVT, והוא האירוע עם הפרוגנוזה הטובה ביותר. חשוב מאוד להתחיל טיפול מהר ככל האפשר מכיוון שכאשר מופיע נמק במעיים, בכל אחת מהאטיולוגיות, התמותה מגיעה ל-90%. הפתופיזיולוגיה של NOMI, שלא כמו בשאר האירועים, היא על רקע אי התאמה בין היצע לביקוש (supply and demand mismatch) בדומה ל-MI Type 2. הגורמים ל-NOMI הם ירידת ל"ד ממושכת עם ירידה בפרפוזיה מכל סוג שהיאספסיס, אנמיה קשה וכל סוג של הלם.

הסימנים והסימפטומים של AMI

הסימנים והסימפטומים בדרך כלל אינם ספציפיים, ולכן זו נחשבת לאבחנה קשה, עד שכבר מאוחר מדי.

- כאבי בטן קשים, דיפוזיים, לא מקומיים, רציפים ולעיתים התקפיים
- לעיתים הכאבים לא מגיבים לטיפול באופיאטים
- סימני חסימת מעיים, בחילות והקאות מופיעים אצל כ-75% מהמטופלים
- היעדר תיאבון
- שלשולים או עצירות
- בטן נפוחה
- יציאות דמיות
- אם מופיע נמק - סימנים להלם ספטי

האבחנה המבדלת (Differential diagnosis)

- תסביב שחלה (ovarian torsion)
- תסביב אשך (testicular torsion)
- מחלת קרוהן (Crohn's disease)

- מחלת קוליטיס חריפה (acute colitis)
- דיסקציה (קרע) של האאורטה (aortic dissection)
- אפנדיציטיס (דלקת התוספתן)
- פילונפריטיס (דלקת כליות)
- חסימת מעיים (bowel obstruction)
- קרע ושטי (Boerhaave syndrome)

גורמי הסיכון

גורמי הסיכון לאירוע מזנטרי זהים לגורמי הסיכון באוטם שריר הלב (MI), בשבץ ובתסחיף ריאות (PE).

- גורמי סיכון ל-CVD
- פרפור עליות
- הפרעות קרישת יתר
- מחלה ממארת

אבחון

אבחנה של אירוע מזנטרי היא אחת האבחנות הקשות ביותר בעולם הרפואה הדחופה. דרושה רמת חשד גבוהה. בדרך כלל הבעיה מתגלית ב-CT אנגיו (CTA) של המעיים. במעבדה נצפית עליה ב-D-dimers, D.O.

הטיפול ב-AMI

טיפול באירוע מזנטרי חריף הוא תחרות נגד השעון. יש להתחיל בטיפול במהירות האפשרית כדי למנוע היווצרות רקמה נמקית במעי. הפרוצדורות הטיפוליות הן בעיקר כירורגיות, במיוחד אם המעי כבר נמק. יש לזהות את האטיולוגיה ולטפל בהתאם. אם יש מחלות נלוות כגון ספסיס, אנמיה קשה, הלם, מטפלים במקביל גם בהן.

אף שהטיפול הוא בעיקר ניתוחי, הגורם העיקרי לאירוע מזנטרי הוא ורידי (MVT) והטיפול באטיולוגיה זו הוא בעיקר תרופתי.

תרופות אפשריות

- פפברין מרפה שרירים חלקים
- הפריין
- קומדין
- אנטיביוטיקה רחבת טווח
- פיברינוליזיס: אלטפלאז, רטפלאז, סטרפטוקינאז

עקרונות הטיפול בדימומים

אירועים תרומבטיים או תרומבואמבוליים הם גורם מרכזי למוות ולתחלואה רבה במטופלים מבוגרים. אפשר לסווג פתולוגיות אלו כפתולוגיות של הקשיש (ראו בתחילת הפרק גורמי סיכון ל-CVD).

לעומת זאת, מטופלים צעירים, עד גיל 40, לא נוטים להגיע לחדר הצנתורים. גורם המוות המוביל בחמשת העשורים הראשונים לחיים הוא טראומה. טראומה מוגדרת כהרס של רקמות הגוף מאנרגיית חום או תנועה. כל רקמות הגוף יכולות להיפגע ישירות מטראומה. עקרונות הטיפול בנפגע מופיעים בפרק 2, ויש לזכור שהדאגה הראשונה היא לנתיב אוויר, למצב נשימתי והמודינמי ולפינוי הנפגע לבית החולים בהקדם האפשרי.

יש לנקוט בכל האמצעים הזמינים כדי למנוע התפתחות אצידוזיס (חמצת), קואגולופתיה (הפרעות קרישה) והיפותרמיה. שלושת המצבים האלה - אצידוזיס, קואגולופתיה והיפותרמיה - מכונים משולש המוות בטראומה. כל אחד מגורמים אלו מקושר לגורם אחר, והשפעתם על פרוגנוזת המטופל היא עצומה.

כדי לבצע את כל הפעולות האלה כראוי יש לפעול בצורה סכמתית, ולהקפיד במיוחד על עצירת דימומים.

דימום: ההגדרה

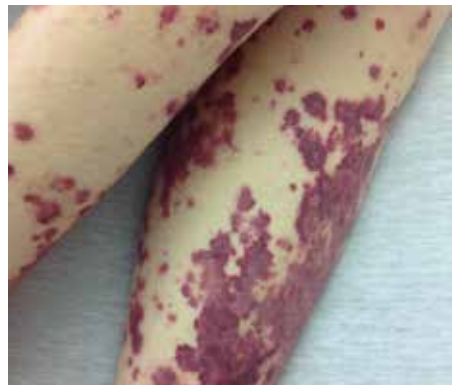
דימום (hemorrhage) מוגדר כיציאת הדם מכליו. כלומר נוזל הדם יוצא מתוך כלי הדם לחלל אחר או לסביבה החיצונית. דימום המוביל לירידה בפרפוזיה הסיסטמית נקרא הלם המורגי, הלם דמי (hemorrhagic shock).

כאשר הדימום מצטבר בין רקמות הגוף, המצב נקרא שטף דם המטומה (hematoma), תלוי במאפייניו.

- שטף דם מחוץ לקרום המוח הקשה (dura matter) מתחת לגולגולת נקרא המטומה אפידורלית (epidural hematoma).
- שטף דם מתחת לקרום המוח הקשה, בין הקרומים, נקרא המטומה סובדורלית (subdural hematoma).
- שטף דם תת־עורי נקרא המטומה סובדרמלית (subdermal hematoma).

המטומה תת־עורית אפשר לחלק לשלוש קטגוריות, על פי גודל הדימום:

- **פטכיה** (petechiae): המטומה בקוטר של 1 עד 3 מ"מ (תמונה 10.4)
- **פורפורה** (purpura): המטומה בקוטר של 3-10 מ"מ
- **אכימוזה** (ecchymosis): המטומה בקוטר של 10 מ"מ ומעלה



תמונה 10.4 פטכיות

פטכיות ברגליים.

(מזכה: DrFOJr.Tn - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24933117>)